Клинические рекомендации

Аллергический ринит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J30.1** — Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений **J30.2** — Другие сезонные аллергические риниты **J30.3** — Другие аллергические риниты **J30.4** — Аллергический ринит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 11.07.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/261_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Главное 3

2. Клиника и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Классификация 3

2.3 Жалобы 3

2.4 Осмотр 4

3. Диагностика 4

3.1 ЛОР-осмотр 4

3.2 Аллергообследование 4

3.3 Анализы 5

3.4 Лучевая и функциональная диагностика 5

3.5 Дифференциальная диагностика 5

4. Лечение 5

4.1 Ступени лечения 5

4.2 Антигистаминные препараты внутрь 6

4.3 Назальные глюкокортикостероиды 6

4.4 Антигистаминные спреи и комбинации 7

4.5 Монтелукаст и кромоглициевая кислота 7

4.6 Сосудосуживающие препараты 7

4.7 Тяжёлое течение 8

4.8 Без лекарств 8

4.9 Аллерген-специфическая иммунотерапия 8

4.10 Хирургическое лечение 8
4.11 Нетрадиционные методы 8
5. Дети, беременность, кормление грудью 9
5.1 С какого возраста можно детям 9
5.2 Беременность и кормление грудью 9
6. Контроль лечения 9
7. Наблюдение, профилактика, госпитализация 10
8. Источник и актуальность 10
8.1 Неточности в самом тексте КР 10

1. Главное

- Диагноз ставят, когда хотя бы два из четырёх симптомов (заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в носу) беспокоят ежедневно не меньше часа, прослеживается связь с аллергеном и аллергообследование положительное.
- Лечение подбирают по ступеням. На первой назначают один препарат: антигистаминный внутрь или в нос, кромоглициевую кислоту или монтелукаст. На второй предпочтителен назальный глюкокортикостероид. На третьей к нему добавляют один-два препарата из первой ступени, а четвёртая — омализумаб, который назначает только специалист.
- Назальные глюкокортикостероиды действуют сильнее антигистаминных препаратов внутрь и кромоглициевой кислоты, особенно при выраженной заложенности.
- Сосудосуживающие капли назначают только при обострении с выраженной заложенностью и только коротким курсом, на 3–7 дней.
- Контроль оценивают по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» на первом приёме и через 2–4 недели лечения.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Аллергический ринит — IgE-опосредованное воспаление слизистой оболочки носа, которое развивается под действием аллергенов. Хотя бы два симптома — заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в полости носа — проявляются ежедневно в течение часа и дольше.

2.2 Классификация

По причине выделяют сезонный, круглогодичный (бытовой) и профессиональный ринит. По течению — интермиттирующий, когда симптомы беспокоят меньше 4 дней в неделю или меньше 4 недель в году, и персистирующий, когда больше 4 дней в неделю и больше 4 недель в году.

При лёгком течении симптомы не мешают сну и дневным делам. При среднетяжёлом мешают работе, учёбе, спорту и нарушают сон. При тяжёлом без лечения пациент не может нормально работать, учиться и спать. Кроме того, различают обострение и ремиссию.

В диагнозе указывают аллергены, к которым выявлена повышенная чувствительность.

Отдельно выделяют локальный аллергический ринит. Симптомы типичные и чётко связаны с аллергеном, но кожные пробы и специфические IgE в крови отрицательны. Специфические IgE в носовом секрете в России не определяют, а назальные провокационные тесты положительны.

2.3 Жалобы

Основные жалобы — заложенность носа с дыханием ртом, сопением, храпом и изменением голоса; водянистые выделения; чихание, часто приступами по утрам; зуд, реже жжение в носу, иногда зуд нёба и глотки. Пациенты трут кончик носа ладонью («аллергический салют»), из-за чего появляется поперечная складка на носу. На поздних стадиях снижается обоняние.

Жалобы и анамнез собирают у каждого пациента с подозрением на аллергический ринит. При круглогодичной форме ведущий симптом — заложенность носа со слизистыми выделениями, при сезонной — приступы чихания, зуд и ринорея. Важно расспросить о связи симптомов с аллергеном и об аллергических болезнях у пациента и кровных родственников.

Из-за обильных выделений и нарушения проходимости слуховых труб бывают раздражение и отёк кожи над верхней губой и у крыльев носа, носовые кровотечения после сморкания, боль в горле и покашливание, боль и треск в ушах при глотании, снижение слуха.

При сезонном рините часто встречается оральный аллергический синдром — перекрёстная непереносимость свежих фруктов, овощей, орехов и семян. Проявления разные: от зуда во рту до анафилаксии.

2.4 Осмотр

Всем пациентам осматривают верхние дыхательные пути, проводят общий осмотр и аускультацию, чтобы не пропустить бронхиальную астму, конъюнктивит и атопический дерматит. Характерны затруднённое носовое дыхание, приоткрытый рот, тёмные круги под глазами, мацерация кожи над верхней губой, отёчность лица.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят, когда есть характерные жалобы (два симптома из четырёх, ежедневно не меньше часа), анамнез указывает на связь с аллергеном или на другие аллергические болезни и аллергообследование положительно.

Пациента ведут вместе оториноларинголог и аллерголог-иммунолог. Оториноларинголог проводит риноскопию и эндоскопию, дифференциальную диагностику, выявляет осложнения и анатомические нарушения и определяет показания к операции. Аллерголог-иммунолог ставит кожные и провокационные тесты, оценивает их, исключает астму и решает вопрос об аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

3.1 ЛОР-осмотр

Переднюю риноскопию проводят всем. Обычно видны отёк носовых раковин и много водянистого секрета. Слизистая ярко-красная при обострении сезонного ринита и цианотичная или серая при круглогодичном, бывает «мраморной» (симптом Воячека), могут быть полипы.

Эндоскопию полости носа, носоглотки и пазух проводят, если стандартное лечение не помогает или ринит осложнённый. Проба с сосудосуживающим средством показывает, обратима ли обструкция.

Контроль симптомов оценивают по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» на первом приёме и через 2–4 недели лечения. Подробнее — в разделе «Контроль лечения».

3.2 Аллергообследование

Если противопоказаний нет, ставят кожные пробы (prick-тесты или скарификационные), чтобы подтвердить аллергическую природу ринита, найти причинные аллергены и решить вопрос об АСИТ.

Пробы ставят в аллергологическом кабинете. На результат влияют возраст младше 5 и старше 60 лет, приём системных глюкокортикоидов, антигистаминных и психотропных препаратов, дермографизм (ложноположительный результат) и недавняя острая аллергическая реакция (ложноотрицательный).

Специфические IgE в крови определяют, если кожные пробы противопоказаны или невозможны, их результат сомнителен или расходится с анамнезом.

По методу ImmunoCAP результат считается положительным при значении больше 0,70 kU/l.

Общий IgE для диагностики не назначают: он неинформативен.

3.3 Анализы

Развёрнутый общий анализ крови назначают при выраженных симптомах в обострении или перед АСИТ. Смотрят эозинофилы; лейкоцитоз со сдвигом влево — повод искать инфекцию, прежде всего острый риносинусит.

При выраженных симптомах в обострении можно сделать цитологию смывов из носа. Для аллергического ринита характерна эозинофилия носового секрета — 10% и больше.

Общий IgE определяют только перед назначением омализумаба (с 12 лет, при тяжёлом течении), потому что по нему рассчитывают дозу.

3.4 Лучевая и функциональная диагностика

Рентгенографию пазух делают при симптомах риносинусита (гнойные выделения, боль в проекции пазух, головная боль, температура) или при лейкоцитозе со сдвигом влево.

КТ пазух нужна, если лечение не помогает, обструкция выраженная и длительная, держится аносмия или аллергообследование отрицательное. Прежде всего её делают при подозрении на полипозный риносинусит.

Спирометрию с бронхолитиком проводят при кашле, свистящем дыхании и одышке, а также перед АСИТ, чтобы выявить скрытый бронхоспазм.

Перед инъекционной АСИТ записывают ЭКГ.

3.5 Дифференциальная диагностика

Аллергический ринит отличают от инфекционного ринита, аномалий внутриносовых структур, аденоидов у детей и полипозного риносинусита. Его отличают и от неаллергических ринитов: эозинофильного, лекарственного (НПВП, альфа- и бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, резерпин, долгий приём деконгестантов), гормонального (беременность, пубертат, менструальный цикл, контрацептивы, акромегалия, гипотиреоз), профессионального, атрофического ринита пожилых, пищевого и алкогольного, идиопатического. Кроме того, исключают первичную цилиарную дискинезию и муковисцидоз.

---

4. Лечение

Цель лечения — полный контроль симптомов. Если контакт с аллергеном, табачным дымом или другими раздражителями продолжается, можно добиться лишь уменьшения симптомов.

4.1 Ступени лечения

На любой ступени исключают контакт с аллергеном, при показаниях оперируют сопутствующую патологию и рассматривают АСИТ.

Ступень	Назначения
1-я ступень	Один препарат: антигистаминный внутрь без седативного эффекта, антигистаминный спрей в нос, кромоглициевая кислота в нос или монтелукаст.
2-я ступень	Один препарат, предпочтительно назальный глюкокортикостероид; можно антигистаминный внутрь или в нос либо монтелукаст.
3-я ступень	Назальный глюкокортикостероид вместе с одним или несколькими препаратами: антигистаминным внутрь или в нос, монтелукастом.
4-я ступень	Омализумаб при тяжёлом течении, с 12 лет. Назначает только специалист.
Для быстрой помощи	Сосудосуживающие капли коротким курсом или глюкокортикоиды внутрь.

> Прежде чем переходить на ступень выше, перепроверьте диагноз, приверженность лечению, сопутствующие болезни и анатомические аномалии.

4.2 Антигистаминные препараты внутрь

Антигистаминные препараты без седативного эффекта назначают всем пациентам: они уменьшают зуд, чихание, ринорею и заложенность. Цетиризин в больших дозах вызывает сонливость чаще остальных.

Седативные антигистаминные первого поколения не назначают: они вызывают сонливость, нарушают сон и могут приводить к апноэ во сне.

Препарат	Доза
Дезлоратадин	Взрослым и детям с 12 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 2,5 мг, детям 1–5 лет — 1,25 мг, детям 6–12 месяцев — 1 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки.
Лоратадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–12 лет при весе до 30 кг — 5 мг, больше 30 кг — 10 мг 1 раз в сутки.
Фексофенадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 120 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 30 мг 2 раза в сутки.
Цетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5–10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–6 лет — 2,5 мг 2 раза или 5 мг 1 раз в сутки, детям 1–2 лет — 2,5 мг 2 раза в сутки, детям 6–12 месяцев — 2,5 мг 1 раз в сутки.
Эбастин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10–20 мг 1 раз в сутки. Есть форма для рассасывания под языком.
Рупатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки.
Биластин	Взрослым и детям старше 12 лет — 20 мг 1 раз в сутки.

4.3 Назальные глюкокортикостероиды

Их назначают при среднетяжёлом и тяжёлом течении, особенно при выраженной заложенности. Они сильнее антигистаминных препаратов внутрь и кромоглициевой кислоты и помогают также при глазных симптомах. Возможны сухость, носовые кровотечения, редко перфорация перегородки, поэтому пациента нужно научить правильно вводить спрей.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Мометазон	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддержки — 1 доза; при необходимости до 4 доз. Детям 2–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Флутиказона фуроат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (55 мкг) 1 раз в сутки, для поддержки — 1 доза. Детям 2–12 лет — 1 доза (27,5 мкг) 1 раз в сутки, при необходимости 2 дозы.
Флутиказона пропионат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддержки — 1 доза. Детям 4–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Будесонид	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки, для поддержки — 200 мкг в сутки. Не дольше 3 месяцев.
Беклометазон	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки, это максимальная доза; для поддержки — 1 доза 2 раза в сутки.

4.4 Антигистаминные спреи и комбинации

Антигистаминные спреи быстро уменьшают симптомы, в течение 30 минут. Их назначают отдельно или вместе с другими препаратами; возможна сухость слизистой.

Если нужны и антигистаминный, и гормональный спрей, удобнее назначить один комбинированный.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Азеластин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза (0,14 мг) 2 раза в сутки, с 12 лет при необходимости 2 дозы. Не дольше 6 месяцев.
Левокабастин	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы 2 раза в сутки, при выраженных симптомах 3–4 раза. Если за 3 дня эффекта нет, препарат отменяют.
Азеластин и флутиказон	Взрослым и детям старше 12 лет — 1 доза (137 мкг азеластина и 50 мкг флутиказона) 2 раза в сутки.
Азеластин и мометазон	Взрослым с 18 лет — 1 доза (140 мкг азеластина и 50 мкг мометазона) 2 раза в сутки, курс 2 недели.
Мометазон и олопатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы 2 раза в сутки (в КР указано 50 мкг мометазона и 1200 мкг олопатадина). Детям 6–11 лет только при сезонном рините — 1 доза (25 и 600 мкг) 2 раза в сутки.

4.5 Монелукаст и кромоглициевая кислота

Монелукаст можно назначать при любой тяжести, отдельно или вместе с другими препаратами, но он слабее назальных глюкокортикостероидов.

Если у пациента ещё и бронхиальная астма, монелукаст помогает контролировать обе болезни. Курс — от 1 до 3 месяцев и дольше; по инструкции ограничений по длительности нет.

Если нужны и антигистаминный препарат внутрь, и монелукаст, можно назначить комбинированную таблетку левоцетиризина с монелукастом.

Кромоглициевую кислоту в нос назначают при лёгком течении. Она безопасна, но слабее антигистаминных препаратов, монелукаста и назальных глюкокортикостероидов.

Препарат	Доза
Монелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 10 мг 1 раз в сутки, детям 6–15 лет — 5 мг, детям 2–6 лет — 4 мг (жевательная таблетка) 1 раз в сутки.
Левоцетиризин и монелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 1 таблетка (5 мг и 10 мг) 1 раз в сутки.
Кромоглициевая кислота, спрей	Взрослым и детям старше 5 лет — 1 доза в каждый носовой ход 4 раза в сутки, при необходимости до 6 раз. Когда наступит эффект, можно применять только при контакте с аллергеном. Курс 4 недели.

4.6 Сосудосуживающие препараты

При обострении с выраженной заложенностью их назначают коротким курсом, на 3–7 дней.

Длительные курсы не назначают: после 10 дней развиваются привыкание, отёк слизистой и медикаментозный ринит.

Если нужны и антигистаминный, и сосудосуживающий препарат в нос, можно назначить комбинацию диметиндена с фенилэфрином, не дольше 7 дней.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Оксиметазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы 0,05% раствора 2–3 раза в сутки. Детям 1–6 лет — 1–2 капли 0,025%, детям от 5 недель до года — 1–2 капли 0,01%, до 4 недель — 1 капля 0,01% 2–3 раза в сутки. Курс 3–4 дня.
Ксилометазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза 0,1% раствора 1–3 раза в сутки, детям 2–6 лет — 1 доза 0,05% 1–2 раза в сутки. Не дольше 5–7 дней.
Диметинден и фенилэфрин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы спрея или 3–4 капли 3–4 раза в сутки. Детям 1–6 лет — только капли, по 1–2 капли 3–4 раза в сутки.

4.7 Тяжёлое течение

При тяжёлом обострении или если третья ступень не помогает, можно назначить короткий курс глюкокортикоидов внутрь.

Это четвёртая линия или лечение тяжёлого обострения. Вводить растворы и депо-формы глюкокортикоидов в носовые раковины недопустимо: это грозит тяжёлыми осложнениями вплоть до слепоты. Дозу преднизолона, метилпреднизолона или дексаметазона подбирают индивидуально; преднизолон в таблетках противопоказан детям до 3 лет.

Депо-формы глюкокортикоидов не назначают: побочные эффекты развиваются быстро, вплоть до надпочечниковой недостаточности.

Омализумаб рассматривают с 12 лет при тяжёлом персистирующем течении или тяжёлом обострении, если третья ступень не помогает.

Его вводят подкожно раз в 2 или 4 недели, доза от 75 до 600 мг — по таблице дозирования. При сезонном рините начинают хотя бы за неделю до начала пыления и продолжают до его окончания.

4.8 Без лекарств

Всем пациентам рекомендуют по возможности избегать контакта с аллергеном. Даже частичное ограничение облегчает течение и снижает потребность в лекарствах.

Всем рекомендованы изотонические солевые растворы для носа, в том числе на основе морской воды.

Перед введением назального глюкокортикостероида нос промывают: так препарат лучше контактирует со слизистой, а сухость и кровотечения возникают реже.

4.9 Аллерген-специфическая иммунотерапия

АСИТ рассматривают у всех пациентов в ремиссии, в том числе медикаментозной. Она уменьшает симптомы и потребность в лекарствах, предупреждает развитие астмы и расширение спектра аллергенов.

Показания, противопоказания и выбор аллергена определяет аллерголог-иммунолог, он же назначает АСИТ.

4.10 Хирургическое лечение

Операцию проводят только при сопутствующей патологии; показания определяет оториноларинголог по данным эндоскопии и рентгенологического обследования. Плановые операции в сезон пыления причинных аллергенов не проводят.

4.11 Нетрадиционные методы

Гомеопатию, фитотерапию, гипноз, техники релаксации, ионизаторы воздуха и физиотерапию не рекомендуют: доказательств их пользы нет.

Иглоукалывание можно рассмотреть в составе комплексного лечения.

5. Дети, беременность, кормление грудью

5.1 С какого возраста можно детям

Мометазон и флутиказона фуроат разрешены с 2 лет, флутиказона пропионат — с 4 лет, беклометазон и будесонид — с 6 лет.

Цетиризин и дезлоратадин разрешены с 6 месяцев, лоратадин — с 2 лет. Антигистаминные первого поколения (хлоропирамин, диметинден) разрешены с 1 месяца, но, когда ребёнок дорастёт до нужного возраста, предпочтение отдают препаратам без седативного эффекта.

Монтелукаст в дозе 4 мг разрешён с 2 лет, в дозе 5 мг — с 6 лет.

АСИТ по инструкциям к препаратам проводят с 5 лет.

Назальные глюкокортикостероиды назначают детям в минимальной эффективной дозе, а при длительном применении следят за ростом.

Лучше ограничить препараты с высокой биодоступностью — будесонид (30–40%) и беклометазон (40–50%). У дексаметазона биодоступность больше 80%; это важно помнить, потому что он входит во многие комбинированные капли.

5.2 Беременность и кормление грудью

У беременных нужно помнить о рините беременных: заложенность носа без признаков инфекции и аллергии, которая полностью проходит в течение 2 недель после родов. Выявленная сенсибилизация говорит в пользу аллергического ринита.

Кожные пробы во время беременности и кормления не ставят; вместо них определяют специфические IgE в крови.

Предпочтение отдают ограничению контакта с аллергеном и промыванию носа. Лекарства назначают, если этого недостаточно, взвешивая риск для матери и ребёнка.

Доказательств риска для человека нет у лоратадина, цетиризина и будесонида (категория B по классификации FDA).

В первом триместре лекарства по возможности не назначают, если в них нет жизненной необходимости.

При кормлении грудью лучше ограничиться местными средствами с минимальной биодоступностью: все системные препараты проникают в молоко.

6. Контроль лечения

Визуальная аналоговая шкала — линия длиной 10 см, на которой пациент отмечает, насколько его беспокоят симптомы. Если отметка от 0 до 50 мм, ринит контролируется, если 50 мм и больше — не контролируется.

У подростков и взрослых при отметке 5 см и больше начинают с антигистаминных препаратов на 2–4 недели. Если ринит стал контролируемым, лечение продолжают по потребности и рассматривают АСИТ. Если нет, добавляют назальный глюкокортикостероид или монтелукаст ещё на 2–4 недели. Если и тогда контроля нет, пересматривают диагноз, ищут сопутствующую патологию, рассматривают АСИТ и хирургическое лечение.

Ринит считается контролируемым, если за последние 4 недели не было симптомов, не нарушались сон и дневная активность, а тест «дыхание с закрытым ртом» нормальный. Любое отклонение, в том числе более частая потребность в препаратах быстрой помощи, означает потерю контроля, и тогда можно переходить на ступень выше.

Для теста пациента просят закрыть рот и 30 секунд дышать только носом.

Для дневника симптомов (шкала TNSS) пациент каждый день оценивает чихание, водянистые выделения, заложенность и зуд от 0 до 3 баллов, сумма — от 0 до 12. Врач считает среднее за 7 дней. Дневник ведут в обострение и для оценки эффекта АСИТ.

Отдельно оценивают лекарства: только антигистаминные — 1 балл, назальные глюкокортикостероиды — 2, системные глюкокортикоиды — 3.

7. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Каждому пациенту или его представителям объясняют суть болезни, составляют индивидуальный план лечения и учат управлять болезнью самостоятельно.

Пациенты находятся на диспансерном наблюдении у аллерголога-иммунолога или оториноларинголога: взрослые приходят не реже раза в год, дети — не реже двух раз в год. Наблюдение пожизненное или до стойкой ремиссии длительностью 3 года и больше.

АСИТ используют и для вторичной профилактики: она помогает предупредить астму, утяжеление ринита и расширение спектра сенсибилизации.

При пыльцевой сенсибилизации советуют ограничить перекрёстно-реагирующие продукты и растительные лекарства.

Лечат обычно амбулаторно. Госпитализируют при крайне тяжёлом или осложнённом течении, детей — при тяжёлом обострении с выраженной заложенностью, а также планово для ускоренного курса АСИТ. Выписывают, когда симптомы под контролем или курс АСИТ завершён.

8. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Аллергический ринит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 11.07.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2027 года
Код в рубрикаторе	261_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

8.1 Неточности в самом тексте КР

- Разовая доза кромоглициевой кислоты указана в КР как «2.8 мкг», суточная — как «22.4 мкг». Сверьте с инструкцией в ГРЛС.
- Подпись к алгоритму в приложении Г1 гласит «пациентов, получавших лечение ранее», а в оригинальном названии — «untreated patients», то есть не получавших лечения.
- В тексте доз мометазона и флутиказона фуроата повторяются обрывки фраз; на смысл доз это не влияет.